

SISTEMA INFORMÁTICO PERINATAL: HISTORIA CLÍNICA PERINATAL

Introducción

El Centro Latinoamericano de Perinatología/Salud de la Mujer y Reproductiva (CLAP/SMR) es un centro y unidad técnica de la Oficina Panamericana de la Salud (OPS) que brinda asesoría técnica a los

países de América Latina y el Caribe en el área de la salud sexual y reproductiva.

En 1983, el CLAP/SMR publicó el Sistema Informático Perinatal (SIP). El SIP es un producto de consenso técnico entre cientos de profesionales de la Región convocados periódicamente por el CLAP/SMR para su revisión y forma parte de las herramientas (tool kit) de la OPS para mejoría de la calidad de la atención de madres y recién nacidos.

El SIP está constituido por un grupo de instrumentos originalmente diseñados para uso en los servicios de gineco/obstetricia y neonatología. Estos instrumentos son la Historia Clínica Perinatal (HCP), el carné perinatal, el formulario de aborto, el partograma, hospitalización neonatal, enfermería neonatal y los programas de captura y procesamiento local de datos.

La HCP es un instrumento diseñado para ayudar en las decisiones relacionadas con el manejo clínico individual de la mujer embarazada durante el control prenatal, el parto y el puerperio y del neonato y/o en el ingreso por aborto, incluyendo el período pos-aborto hasta el alta.

Cuando su contenido forma parte de una base de datos, la HCP se convierte en un instrumento útil para la vigilancia clínica y epidemiológica de éstos eventos desde una visión de Salud Pública.

Es esencial que los datos registrados en la HCP sean completos, válidos, confiables y estandarizados.

Historia Clínica Perinatal Regional (anverso)

E se o don significa ALERTA (no indica necesariamente riesgo ni patología subyacente)

HISTORIA CLINICA PERINATAL - CLAP/SMR - OPS/OMS										FECHA DE NACIMIENTO		ETNIA		ALEA BETA		ESTUDIOS		ESTADOCAL		Lugar del parto	
NOMBRE: _____ APELLIDO: _____										da mes año		blanca indígena mestiza negra otras		ninguno primario secundario universitario otras		casado unión estable soltero otro		Lugar del parto			
DOMICILIO: _____										EDAD (años)											
LOCALIDAD: _____ TELEF.: _____										de 15 a 35 más de 35											
FAMILIARES PERSONALES										OBSTETRICOS											
diabetes: ☐ SI ☐ NO hipertensión: ☐ SI ☐ NO pre-eclampsia: ☐ SI ☐ NO edema: ☐ SI ☐ NO otras: ☐ SI ☐ NO										gestas previas: ☐ SI ☐ NO abortos: ☐ SI ☐ NO vaginales: ☐ SI ☐ NO nacidos vivos: ☐ SI ☐ NO viven: ☐ SI ☐ NO											
FIN EMBARAZO ANTERIOR: da mes año EMBARAZO PLANEADO: ☐ SI ☐ NO FRAGASO METODO ANTICONCEPCION: ☐ SI ☐ NO										ULTIMO PREVIO: ☐ SI ☐ NO Antecedente de gemelares: ☐ SI ☐ NO											
GESTACION ACTUAL										EG CONFIABLE											
PESO ANTERIOR: Kg. TALLA: cm. EPO: da mes año										FUMACT: ☐ SI ☐ NO											
CERVIX: ☐ SI ☐ NO										FUMACT: ☐ SI ☐ NO											
GRUPO: ☐ SI ☐ NO										FUMACT: ☐ SI ☐ NO											
TOXOPLASMO: ☐ SI ☐ NO										FUMACT: ☐ SI ☐ NO											
Hb <20 sem: ☐ SI ☐ NO										FUMACT: ☐ SI ☐ NO											
FETOPATOS: ☐ SI ☐ NO										FUMACT: ☐ SI ☐ NO											
Hb <20 sem: ☐ SI ☐ NO										FUMACT: ☐ SI ☐ NO											
VH: ☐ SI ☐ NO										FUMACT: ☐ SI ☐ NO											
SIFILIS: ☐ SI ☐ NO										FUMACT: ☐ SI ☐ NO											
PATOLOGIAS: ☐ SI ☐ NO										FUMACT: ☐ SI ☐ NO											
BACTERIURIA: ☐ SI ☐ NO										FUMACT: ☐ SI ☐ NO											
GLUCEMIA EN AYUNAS: ☐ SI ☐ NO										FUMACT: ☐ SI ☐ NO											
ESTREPTOCOCCO: ☐ SI ☐ NO										FUMACT: ☐ SI ☐ NO											
PREPARACION PARA EL PARTO: ☐ SI ☐ NO										FUMACT: ☐ SI ☐ NO											
CONSEJERIA LACTANCIA MATERNA: ☐ SI ☐ NO										FUMACT: ☐ SI ☐ NO											
SIGNOS DE ALARMA, EXAMENES, TRATAMIENTOS										SIGNOS DE ALARMA, EXAMENES, TRATAMIENTOS											
CONSULTAS ANTERIORES										CONSULTAS ANTERIORES											
PARTO										PARTO											
FECHA DE INGRESO: da mes año										FECHA DE INGRESO: da mes año											
CONSULTAS PRE-NATALES: ☐ SI ☐ NO										CONSULTAS PRE-NATALES: ☐ SI ☐ NO											
CARNE: ☐ SI ☐ NO										CARNE: ☐ SI ☐ NO											
HOSPITALIZ. EN EMBARAZO: ☐ SI ☐ NO										HOSPITALIZ. EN EMBARAZO: ☐ SI ☐ NO											
CORTICOIDES ANTERIORES: ☐ SI ☐ NO										CORTICOIDES ANTERIORES: ☐ SI ☐ NO											
ROTURA DE MEMBRANAS ANTEPARTO: ☐ SI ☐ NO										ROTURA DE MEMBRANAS ANTEPARTO: ☐ SI ☐ NO											
EDAD GEST. al parto: ☐ SI ☐ NO										EDAD GEST. al parto: ☐ SI ☐ NO											
PRESENTACION SITUACION: ☐ SI ☐ NO										PRESENTACION SITUACION: ☐ SI ☐ NO											
TAMANO FETAL ACORDE: ☐ SI ☐ NO										TAMANO FETAL ACORDE: ☐ SI ☐ NO											
ACOMPANANTE: ☐ SI ☐ NO										ACOMPANANTE: ☐ SI ☐ NO											
NACIMIENTO: ☐ SI ☐ NO										NACIMIENTO: ☐ SI ☐ NO											
POSICION PARTO: ☐ SI ☐ NO										POSICION PARTO: ☐ SI ☐ NO											
DESCARGAS: ☐ SI ☐ NO										DESCARGAS: ☐ SI ☐ NO											
OCTOCICOS: ☐ SI ☐ NO										OCTOCICOS: ☐ SI ☐ NO											
PLACENTA: ☐ SI ☐ NO										PLACENTA: ☐ SI ☐ NO											
LIGADURA CORDON: ☐ SI ☐ NO										LIGADURA CORDON: ☐ SI ☐ NO											
TERMINACION: ☐ SI ☐ NO										TERMINACION: ☐ SI ☐ NO											
INDICACION PRINCIPAL DE INDUCCION O PARTO OPERATORIO										INDICACION PRINCIPAL DE INDUCCION O PARTO OPERATORIO											
RECEN NACIDO										RECEN NACIDO											
SEXO: ☐ SI ☐ NO										SEXO: ☐ SI ☐ NO											
PESO AL NACER: ☐ SI ☐ NO										PESO AL NACER: ☐ SI ☐ NO											
EDAD GESTACIONAL: ☐ SI ☐ NO										EDAD GESTACIONAL: ☐ SI ☐ NO											
ARGAR: ☐ SI ☐ NO										ARGAR: ☐ SI ☐ NO											
FALLECE EN LUGAR DE PARTO: ☐ SI ☐ NO										FALLECE EN LUGAR DE PARTO: ☐ SI ☐ NO											
REFERIDO: ☐ SI ☐ NO										REFERIDO: ☐ SI ☐ NO											
MACERADO: ☐ SI ☐ NO										MACERADO: ☐ SI ☐ NO											
ANTIBIOTICO: ☐ SI ☐ NO										ANTIBIOTICO: ☐ SI ☐ NO											
YGLOBULINA: ☐ SI ☐ NO										YGLOBULINA: ☐ SI ☐ NO											
ANTICONCEPCION: ☐ SI ☐ NO										ANTICONCEPCION: ☐ SI ☐ NO											
EGRESO RN										EGRESO RN											
VIVO: ☐ SI ☐ NO										VIVO: ☐ SI ☐ NO											
FALLECE: ☐ SI ☐ NO										FALLECE: ☐ SI ☐ NO											
EDAD AL EGRESO: ☐ SI ☐ NO										EDAD AL EGRESO: ☐ SI ☐ NO											
ALIMENTO ALTA: ☐ SI ☐ NO										ALIMENTO ALTA: ☐ SI ☐ NO											
EGRESO MATERNO										EGRESO MATERNO											
VIVO: ☐ SI ☐ NO										VIVO: ☐ SI ☐ NO											
FALLECE: ☐ SI ☐ NO										FALLECE: ☐ SI ☐ NO											
EDAD AL EGRESO: ☐ SI ☐ NO										EDAD AL EGRESO: ☐ SI ☐ NO											
ALIMENTO ALTA: ☐ SI ☐ NO										ALIMENTO ALTA: ☐ SI ☐ NO											

DESCRIPCION DE CODIGOS EN EL REVERSO

HOPESAVE Regional 2001

Sección: ANTECEDENTES FAMILIARES, PERSONALES Y OBSTÉTRICOS

FAMILIARES		PERSONALES		OBSTÉTRICOS	
no	si	no	si	no	si
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	<		

Drogas.

Se refiere al uso actual de drogas que causan dependencia como: marihuana, cocaína, anfetamínicos, alucinógenos, heroína, entre otras.

Se anotará la respuesta según corresponda (NO/SI). En caso de aborto no se interrogará en el 2° y 3er trimestre.

Alcohol

Se refiere a la ingesta actual de cualquier tipo de bebida con alcohol en su contenido, por ejemplo: vino, cerveza, tequila, pisco, whisky, etc.

GRUPO Rh

Anotar en el recuadro el **grupo sanguíneo (Grupo)** que corresponda (A, B, AB, O).

GAMAGLOBULINA ANTI D

Esta variable está destinada para la aplicación de gamaglobulina anti D durante el embarazo según normas nacionales. En nuestro país es norma la aplicación rutinaria de la gamaglobulina a todas las gestantes Rh negativas no inmunizadas a las 28 semanas de gestación.

TOXOPLAMOSIS

Las normas locales incluyen la realización de esta prueba en el control prenatal, registrar el valor de la prueba (IgG o IgM) según corresponda.

Siempre es aconsejable impartir mensajes educativo-preventivos para disminuir el riesgo de toxoplasmosis congénita, para lo cual se remite a la Publicación Científica CLAP/SMR 1577. En caso de aborto

y aunque en su servicio se realice serología para toxoplasmosis, no se deberá registrar la variable ≥ 20 semanas.

INFECCIÓN POR VIRUS DE INMUNO DEFICIENCIA ADQUIRIDA (VIH)

La Región de las Américas ha adherido a la estrategia global de una generación de niños libre de VIH y sífilis congénita y en garantizar el acceso universal al tratamiento a todas las personas que viven con VIH/SIDA.

Registrar Test VIH: Solicitado si, no o no corresponde (n/c) (en este último caso cuando se trate de una gestante ya diagnosticada). Anotar el resultado de la prueba según corresponda: positivo, negativo o sin dato (s/d) si la prueba fue solicitada y aún no se conoce el resultado; no corresponde (n/c) se registrará en caso que la prueba no haya sido solicitada, de tratarse de una gestante ya diagnosticada o de una gestante que se niega a realizarse la prueba habiendo sido ésta solicitada.

Registrar la información según la edad del embarazo en que fue realizada la o las pruebas (antes de las 20 semanas o a las 20 o más semanas de gestación). Adicionalmente se consignará si ha recibido o no tratamiento

antirretroviral en caso que corresponda. Anotar no corresponde (n/c) en el caso de gestantes con pruebas de VIH negativas.

SÍFILIS (Diagnóstico y tratamiento)

La sífilis congénita sigue siendo un problema relevante de salud pública en la Región. La OPS a pedido de los ministros de salud de los países miembros ha puesto en marcha “El plan para la eliminación de la sífilis

congénita en las Américas”, lo que se complementa con la estrategia denominada “una generación de niños libre de VIH y sífilis congénita”.

La estrategia para la eliminación de la sífilis congénita incluye el tamizaje en la primera consulta prenatal, la promoción de un control prenatal temprano y la disminución del riesgo de reinfección mediante tratamiento a las parejas sexuales y consejería sobre el uso del condón.

Las pruebas de detección utilizadas pueden ser No Treponémicas o Treponémicas. Se sugiere que

las pruebas de detección se realicen en dos oportunidades, una al momento de la captación en la primera

visita prenatal (antes de las 20 semanas de gestación) y otra en el tercer trimestre. En caso de prueba No Treponémica se marcará (-) cuando la prueba fue no reactiva, (+) si fue reactiva y (S/D) sin dato.

En las pruebas Treponémicas se agrega la opción (N/C) cuando no corresponda (ej.: recuerdo inmunológico de infección previa)

A las mujeres con pruebas reactivas se les deberá tratar, brindar consejería e información sobre la enfermedad, sus riesgos y la necesidad de tratar a sus parejas sexuales y eventualmente al niño después del

nacimiento. A las mujeres con prueba negativa proveerles información acerca de cómo prevenir las infecciones de transmisión sexual.

Registrar (ya sea antes o después de las 20 semanas de embarazo) la semana de gestación en que fue realizada la o las pruebas. Para cada una marcar según corresponda. La HCP incluye las opciones para registrar la semana de gestación en que se realizó el tratamiento, si no fue realizado (NO), si se desconoce (S/D) o no corresponde (N/C).

De la misma forma se registrará el tratamiento de la pareja. (Consultar publicación científica CLAP/SMR N° 1577)

CHAGAS

La enfermedad de chagas (infección por tripanosoma cruzi) es encontrada exclusivamente en el continente americano. Es considerada endémica en 21 países.

Las actividades consideradas esenciales para el control de esta enfermedad son el control vectorial y el despistaje de pruebas serológicas para T. cruzi en los bancos de sangre. En aquellos países que la transmisión vectorial ha sido eliminada, la transmisión vertical de la madre al feto es la única forma de mantenimiento de la enfermedad.

Tanto que para algunos países el Chagas durante la gestación se ha transformado en una enfermedad centinela.

Registrar el resultado de la Prueba de Chagas (Negativa/Positiva/No se hizo) según corresponda.

ESTREPTOCOCCO B 35 - 37 semanas

La infección por Streptococo grupo B es considerada una causa importante de morbilidad y mortalidad neonatal.

La estrategia principal para disminuir esta infección en los recién nacidos es la detección durante el embarazo del estreptococo del grupo B (entre las 35 y 37 semanas) a través de la toma mediante hisopado vaginal y rectal.

Si la realización de esta prueba es parte de las normas de su país la HCP ha incluido un espacio para registrar el resultado de la prueba (NEGATIVO/POSITIVO/NO SE HIZO), según corresponda.

En caso de atención por aborto no aplica llenar esta variable.

PREPARACIÓN PARA EL PARTO

El término preparación para el parto tiene varios significados e incluye conceptos muy variados, el principal es garantizar el acceso para su atención (plan de parto), además es una oportunidad para informar a la mujer y su familia acerca de los cambios que ocurren en la gestación y aquellos esperados durante el parto y el puerperio; preparar a los padres para enfrentar mejor su nuevo rol; entrenar en psicoprofilaxis (técnicas de relajación y respiración); aumentar la percepción de autocontrol de la mujer, entre otros.

CONSEJERÍA EN LACTANCIA MATERNA

Se entiende por consejería la entrega reglada y oportuna de la siguiente información:

- Beneficios de la leche materna y los riesgos de la alimentación con leche artificial.
- Formas de amamantar.

- Los cambios en la leche materna después del parto y
 - Discutir las dudas y preguntas de la gestante.
- También es apropiado informar en este momento sobre los derechos del niño.

Sección:
ENFERMEDADES (PATOLOGÍAS MATERNAS)

ENFERMEDADES		ninguna		1 ó más															
		no	si	no	si														
		☐	☐	☒	☐														
		☐	☐	☒	☐														
		☐	☐	☒	☐														
		☐	☐	☒	☐														
		☐	☐	☒	☐														
		☐	☐	☒	☐														
		☐	☐	☒	☐														
		☐	☐	☒	☐														
		☐	☐	☒	☐														
		☐	☐	☒	☐														
		☐	☐	☒	☐														
		☐	☐	☒	☐														
		☐	☐	☒	☐														
		☐	☐	☒	☐														
		☐	☐	☒	☐														
		☐	☐	☒	☐														
		☐	☐	☒	☐														
		☐	☐	☒	☐														
		☐	☐	☒	☐														
		☐	☐	☒	☐														
		☐	☐	☒	☐														
		☐	☐	☒	☐														
		☐	☐	☒	☐														
		☐	☐	☒	☐														
		☐	☐	☒	☐														
		☐	☐	☒	☐														
		☐	☐	☒	☐														
		☐	☐	☒	☐														
		☐	☐	☒	☐														
		☐	☐	☒	☐														
		☐	☐	☒	☐														
		☐	☐	☒	☐														
		☐	☐	☒	☐														
		☐	☐	☒	☐														
		☐	☐																

En esta sección de la HCP se registrarán todas las patologías ocurridas en el embarazo, parto y puerperio. Se recomienda llenarla conforme se vayan haciendo los diagnósticos. Es así que las complicaciones que aparecieron durante el embarazo estarán registradas al momento del parto y aquellas que ocurrieron al momento del parto estén registradas al momento del egreso. Al momento del egreso se revisará y anotará cualquier complicación detectada en el puerperio.

Sección: RECIÉN NACIDO

RECIE N NACIDO				P. CEFALICO cm		EDAD GESTACIONAL		PESO E.G.		APGAR (min)		REANIMACION		FALLECE en LUGAR de PARTO	
SEXO f ☒ m ☐		PESO AL NACER 3230 g		365		370		FUM ☒ ECO ☒		1ª 09 5ª 10		estimulac. ☒ no ☐ si ☐ aspiracion ☒ no ☐ si ☐ mascara ☒ no ☐ si ☐ oxigeno ☒ no ☐ si ☐ masaje ☒ no ☐ si ☐ tubo ☒ no ☐ si ☐		no ☒ si ☐	
no definido ☒		<2500 g ☐ ≥4000 g ☐		LONGITUD cm 490		ESTIMADA ☐								REFERIDO alaj. conj. ☒ neona. tolog. ☐ otro hosp. ☐	
DEFECTOS CONGENITOS ☒ no ☐ menor ☐ mayor ☐		ENFERMEDADES ninguna ☒ 1 o más ☐				VIH en RN Expuesto Tto. no ☒ no ☐ si ☐ si ☐ s/d ☐ s/d ☐ n/c ☒		TAMIZAJE NEONATAL VDRL Tto. - ☒ no ☐ + ☐ si ☐ no, se hizo ☐ n/c ☐ s/d ☐		TSH Hbpatia Bilirrub Toxo IgM - ☐ ☐ ☐ ☐ + ☐ ☐ ☐ ☐ no, se hizo ☐ ☐ ☐ ☒		Meconio 1ª día no ☐ si ☒			